세일즈혁신 교안

설계사 교육 · 입원적정성 편

입원인 줄 알았는데 통원이었다

입원적정성 , 입원이 통원이 되는 시대의 보장 설계

메리츠화재 세일즈혁신 2026. 10. 23 (금)

왜 논란인가 · 고객이 손해 보는 사례 · 의료 · 건보 · 실손의 배경 · 실손 재매입 · 당사 특약 점검과 트렌드

병원 침대에 누웠다고 입원이 아니다

6h

병원에 머문 시간이 짧으면 입원이 아니라
통원으로 본 분쟁 사례의 기준선 . 자세한 내용은
2 부

한 장 요약 . 입원은 줄고 심사는 는다 , 그래서 보장은 「입원」이 아니라 「치료 행위」에 걸어야 한다

주 : 수치는 출처를 붙였고 , 출처가 없는 값은 「추정」으로 표시했다 . 특약 이름은 당사 약관 명칭 그대로다

01 · 1 부

왜 논란인가

입원의 뜻은 약관이 정하고 , 판정은 심평원과 보험사가 한다 . 고객은 침대에 누운 사실만 기억한다 . 세 시선이 다르니 분쟁이 생긴다

02 · 2 부

고객이 손해 보는 사례

백내장 다초점 , 당일 입퇴원 , 도수치료 입원 , 하이푸 · 맘모톰 , 요양 · 한방병원 , 응급실 체류 . 여섯 사례 모두 「입원」이 「통원」으로 바뀌며 한도가 줄었다

03 · 3 부 ·4 부

네 가지 배경

의료기술은 재원일수를 줄이고 , 건보 재정은 입원을 억제하고 , 실손 손해율은 심사를 늘리고 , 제도는 비급여를 관리한다 . 네 힘이 한 방향이다

04 · 5 부 ·6 부

당사 특약과 트렌드

입원이 지급 조건인 특약 (입원일당 계열) 은 설명 의무가 커지고 , 치료 행위가 조건인 특약 (수술비 · 치료비 · 통원일당 · 통합치료비) 은 가치가 오른다

설계 한 줄 정리 : 「며칠 입원했나」가 아니라 「무슨 치료를 받았나」로 보장을 설명하고 설계한다

여섯 부분 , 질문 하나

「고객이 입원했다고 믿는 순간 , 보험은 무엇을 보고 있는가」

01 **입원적정성이란**
약관의 입원 정의 · 심사 제도 · 세 시선

02 **고객이 손해 보는 사례**
여섯 장면 , 입원이 통원이 되는 순간

03 **네 가지 배경**
의료기술 · 건보 재정 · 실손 손해율 · 제도

04 **실손 재매입과 5 세대**
1~2 세대 재매입 · 5 세대 구조 · 고객 선택

05 **당사 특약 점검**
논란 소지 특약 · 가치가 오르는 특약 · 잠재력 순위

06 **현장 실천**
상담 화법 · 입원 전 안내 5 가지 · 정리

진행 90 분 기준 . 각 부 끝의 「한 줄 정리」만 모아도 교육의 뼈대가 된다

PART 01

입원적정성이란

병원 침대 위의 입원과 약관이 정한 입원은 다르다 . 그 틈에서 논란이 생긴다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5 세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

약관의 「입원」은 네 가지 요건을 모두 채워야 한다 . 하나라도 빠지면 침대에 누웠어도 입원이 아니다

① **의사가 치료가 필요하다고 인정**

의사 · 치과의사 · 한의사의 판단이 먼저다 . 환자가 원해서 하는 입원은 요건이 아니다

② **자택 등에서 치료가 곤란**

집에서 할 수 있는 치료 (경구약 · 단순 관찰) 는 입원의 이유가 되지 못한다

③ **의료기관에 입실**

의료법상 병원 · 의원 . 요양병원 · 정신병원 · 한방병원을 빼는 특약이 많다 (아래 원문)

④ **의사의 관리 하에 치료에 전념**

입실 뒤 외출 · 외박 , 관찰 · 처치 기록이 없는 체류는 「전념」으로 보지 않는다

당사 약관 원문 · 질병입원일당 계열

「입원」이라 함은 의사가 치료가 필요하다고 인정한 경우로서 , 자택 등에서의 치료가 곤란하여 의료법 제 3 조 제 2 항에서 정한 국내의 병원 , 의원 (단 , 국내의 요양병원 , 정신병원 , 한방병원은 제외됩니다) 에 입실하여 의사의 관리 하에 치료에 전념하는 것을 말합니다 .

「 6 시간」은 약관 본문이 아니라 복지부 고시와 판례에서 온 보조 기준이다 . 약관이 묻는 것은 「필요 · 곤란 · 입실 · 전념」이다

출처 : 당사 특약 약관 (tool_body.js 수록 원문 , 요양 · 정신 · 한방병원 제외 문구는 특약별로 다름) · 손해보험협회 실손 안내 (계속 6 시간 이상 체류) · 대법원 2006.1.12 선고 2004 도 6557(체류시간만으로 판단 불가 , 증상 · 진단 · 치료 내용 종합). 실손 표준약관 원문의 6 시간 문구 유무는 미확인

같은 하루 병원에 있어도 보험은 네 가지로 나눈다 . 고객이 아는 것은 「입원」 하나뿐이라 셋은 설명이 필요하다

구분	무엇인가	보험에서 보는 눈	당사 특약 예 (약관 명칭)
입원	의사가 필요 인정 + 자택 치료 곤란 + 입실 + 관리 하 전념	입원일당 · 입원의료비의 지급 전제 . 체류 시간 · 관찰 기록 · 개별 필요성을 본다	질병입원일당 (1 일이상) · 상급종합병원 질병입원일당 · 간병인사용 질병입원일당 (plus)
낮병동 입원	입원실 없이 6 시간 이상 관찰 · 치료 후 당일 귀가 (복지부 고시 입원료 산정)	실손은 대개 입원으로 본다 . 일반 입원일당은 특약에 따라 지급 대상이 아닐 수 있다	종합병원암직접치료낮병동입원일당 (급여 , 1 일 1 회한 , 연간 20 일한도)
응급실 체류	응급실에서 처치 · 관찰 뒤 귀가 . 병실 배정 없음	입원이 아니다 . 응급실 내원 자체를 보장하는 특약이 따로 있다	응급실내원비 (응급) · 응급실내원비 (1-3 등급)
통원	입원하지 않고 의사 관리 하에 치료 (약관 정의)	실손은 통원 한도 (세대별 20~30 만원) 로 지급 . 정액 특약은 치료 행위 자체를 본다	뇌혈관질환통원일당 (연간 30 회한) · 암직접치료통원일당 (상급종합병원) · 수술비 · 치료비 계열

입원일당은 「입원」 한 칸만 본다 . 통원일당 · 응급실내원비 · 수술비 · 치료비는 나머지 세 칸을 메운다

출처 : 당사 약관 「입원」 · 「통원」 · 「낮병동 입원 (급여) 」 · 「응급실」 정의 (tool_body.js) · 심평원 낮병동 입원료 안내 (관찰에만 최소 6 시간) · 금감원 2025.3.10 유의사항 (통원 한도 20~30 만원). 응급실 · 낮병동의 통원 판정 판례는 공신력 있는 자료가 없어 약관 구조로만 설명한다

「입원적정성」은 두 절차에서 쓰인다 . 수사기관이 의뢰하는 심평원 심사와 , 보험사가 지급을 심사하며 하는 의료자문 . 현장 분쟁의 대부분은 뒤쪽이다

형사 · 보험사기방지특별법 제 7 조

심평원 입원적정성 심사

수사기관 의뢰 → 자문회의 → 공공심사위 의결 → 수사기관 통보

허위 · 과다 입원 의심 건을 수사기관만 의뢰할 수 있다 . 진료기록 · 간호기록으로 입원 필요성과 기간을 판단한다 (심평원 공고 2024-193 호 , 2024.8.14 시행). 연평균 의뢰 약 1 만 5 천 건 , 미결은 2015 년 3,300 건에서 2020 년 8 월 35,905 건으로 늘고 평균 처리일수는 98 일에서 761 일이 됐다 . 대법원 (2018) 은 이 회신의 형사 증거능력을 부정했다 . 심평원 판단이 곧 유죄는 아니다 .

민사 · 약관 해석과 지급심사

보험사 의료자문 · 지급심사

청구 → 서류 심사 → 의료자문 → 입원 → 통원 판정

고객이 겪는 「입원이 통원이 됐다」는 거의 여기서 일어난다 . 2025 년 상반기 손보 청구 4,581 만 건 중 의료자문 22,435 건 , 그중 2,347 건 (10.5%) 부지급 . 손보 실손 분쟁은 2024 년 7,264 건이며 도수치료 · 백내장 · 무릎주사 세 항목이 53% 다 . 2026.9.14 금감원은 「자체 판단 가능한 사안까지 과도한 자문으로 지급이 지연된다」며 주치의 소견 검토를 먼저 하라고 요구했다 .

둘을 섞어 말하면 고객에게는 「보험사기 의심」으로 들린다 . 통원 판정은 약관 해석 , 심평원 심사는 수사의 문제다

출처 : 데일리메디 2024.8(심평원 공고) · 법무법인 지평 뉴스레터 2024.8 · 메디칼타임즈 (2020 국감 , 백종헌 의원실) · 청년의사 · 허영 의원실 (금감원 자료 , 2025.10) · 금감원 제 2 차 금융소비자보호 토론회 2025.11.18(이투데이) · 한국일보 2026.9.14. 전국 「입원 부적정」 판정 비율은 공개 통계가 없다

논란의 뿌리는 세 시선이 다르다는 것 . 고객은 침대를 , 병원은 수가를 , 보험사는 약관을 본다

고객

「침대에 누워 하루 잤으니 입원이다」

입원 여부를 자기가 정했다고 믿는다 . 통원 판정을 받으면 보험사가 약속을 어겼다고 느낀다 . 2025 년 손보 민원 48,281 건의 52.8% 가 보험금 산정 · 지급이다

병원

「환자 안전과 수가를 보면 입원이 낫다」

백내장 · 하이푸 · 정맥류 · 줄기세포 주사에서 환자별 상태 구분 없이 입원을 일괄 처방한 사례가 판결에 등장한다 . 병상 OECD 3 배인 구조가 입원을 쉽게 만든다

보험사 · 법원

「약관의 입원 요건을 채웠는가」

체류 시간 , 관찰 · 처치 기록 , 같은 날 통원으로 가능했는가를 본다 . 대법원 2025.1.23(백내장) 과 2026.6.11(하지정맥류) 이 기준을 굳혔다

기준이 바뀌면 보험사는 2 개 이상 채널로 안내하고 최소 3 영업일 뒤 적용해야 한다 (금감원 행정지도 , 2026.6.22 시행). 2022 년 백내장 판결 뒤 일괄 기준 변경으로 생긴 혼란이 계기였다

세 시선을 한 자리에 놓고 설명하는 사람이 설계사다 . 「입원하면 나온다」가 아니라 「이런 입원이면 나온다」로 말한다

출처 : 금감원 「 2025 년 금융민원 동향」 2026.4.21(쿠키뉴스) · 데일리메디 2026(한방병원 줄기세포 주사 판결) · 대법원 2024 다 305643(2025.1.23) · 대법원 2026 다 202566(2026.6.11) · 머니투데이 2026.6.21(행정지도) · 보건복지부 OECD 보건통계 2026 분석

법원과 보험사가 「통원」이라 말할 때 보는 여섯 가지 신호 . 고객의 입원 전에 이 여섯을 미리 확인하면 분쟁의 절반은 사라진다

6 시간 미만 체류

수술 준비부터 종료까지 2 시간 , 그 뒤 처치 없음 (백내장 2022). 다만 6 시간은 절대 기준이 아니다 (2004 도 6557, 2026.5 항소심)

관찰 · 처치 기록 없음

진료기록에 입원 뒤 관찰 · 처치 · 부작용 기록이 없으면 「실질적 입원」이 아니다 (대법원 2025.1.23, 원고 137 명 패소)

같은 날 통원으로 가능

양다리 정맥폐쇄술을 하루씩 나눠 이틀 입원 . 「같은 날 통원 수술 가능 , 마취 두 번 할 사정 없음」 (대법원 2026.6.11)

환자별 구분 없는 일괄 입원

한방병원 줄기세포 주사 , 원고 9 명 중 7 명 기각 . 병원이 환자 상태 구분 없이 입원을 일괄 처방

치료 필요성과 입원 적정성은 별개

하이푸 시술은 필요했지만 입원은 아니었다 . 통원의료비 7 만 5 천원만 인정 , 입원비 전부 기각

반대로 , 합병증이 있으면 입원

출혈로 도뇨관을 당일 제거 못 한 환자 , 약 6 시간 체류 → 입원 인정 , 미지급 402 만원 지급 판결 (2026.5)

여섯 신호 중 다섯은 「기록」의 문제다 . 입원 전에 「왜 입원이 필요한지」를 의사에게 묻게 하면 기록이 남는다

출처 : 서울고법 2021 나 2013354(2022.1.20, 대법원 2022.6.16 확정) · 대법원 2024 다 305643(2025.1.23, 금감원 2025.3.10 유의사항) · 대법원 2026 다 202566(2026.6.11, 연합 2026.7.23) · 데일리메디 2026(한방병원 줄기세포) · 메디컬투데이 2026.5.15(하이푸) · 연합 · 의협신문 2026.5.12(402 만원 판결 , 수술명 미보도)

PART 02

입원이 통원이 되는 순간

여섯 장면 . 고객은 모두 「입원했다」고 믿었고 , 결과는 통원 한도이거나 0 원이었다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5 세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

사례 1. 백내장 다초점렌즈 수술 , 「입원해서 받았다」고 믿은 수백 명이 통원 한도만 받았다

고객의 생각

「수술하고 입원실에서 쉬다 왔어요 . 수술비 1,000 만원 중 실손으로 800~900 만원은 나오겠지요」

판정

통원 . 수술 준비부터 종료까지 약 2 시간 , 그 뒤 관찰 · 처치 없음 . 실손 통원 한도만 지급

서울고법 2022.1.20 선고 (대법원 2022.6.16 확정). 2025.1.23 대법원은 원고 137~141 명 · 보험사 11 곳 사건에서 「 6 시간 미만이거나 관찰 · 처치 · 부작용 기록이 없으면 실질적 입원이 아니다」로 원고 패소 . 「약관에 체류시간이 없어 설명의무 위반」 주장도 기각

고객이 본 불이익

800 만원 → 20~30 만원

금감원 유의사항 (2025.3.10): 수술비 1,000 만원 기준 , 입원 인정 시 800~900 만원 , 불인정 시 통원 한도 20~30 만원

설계사 포인트

백내장은 OECD 평균 95% 가 당일수술이다 . 다초점렌즈 자체는 보상 대상이니 「입원」을 약속하지 말고 「수술 정액」으로 설명한다 . 당사 130·131 대질병수술비 [백내장], 안과질환수술비는 입원 여부를 묻지 않는다

출처 : 서울고법 2021 나 2013354·2013361 · 김앤장 2022.6 · 보험연구원 판례검토 · 대법원 2024 다 305643(2025.1.23) · 금감원 보도자료 2025.3.10(뉴시스 · 리걸타임즈) · 서울중앙지법 2024 나 44725(2025.3.19)

사례 2. 하지정맥류 , 양다리를 하루씩 나눠 이틀 입원 . 대법원은 「같은 날 통원으로 가능했다」고 봤고 당사도 9 월부터 심사를 조였다

고객의 생각

「양쪽 다리를 다 해야 해서 이틀 입원했어요 . 병원이 그렇게 잡아 줬고요」

판정

형식적 입원 . 같은 날 통원 수술 가능 , 마취를 두 번 할 사정 없음 . 실손 입원의료비 지급 불가

대법원 2026.6.11 선고 2026 다 202566. 2023.3 이틀 입원해 양다리 정맥폐쇄술을 하루씩 받은 사건 . 판결 뒤 삼성화재 · 메리츠화재 등이 사전안내문을 보내고 2026.9.9 시술분부터 입원 필요성 심사를 강화했다 . 학회는 「특정 환자의 형식적 입원을 부정한 것 , 확대해석 말라」

고객이 본 불이익

입원 2 일 → 0 원

입원의료비 전액 부지급 . 입원일당 특약이 있었다면 그 역시 「입원」 요건 미충족

설계사 포인트

당사가 직접 안내문을 보낸 사안이다 . 정맥류 고객에게는 「입원 2 일」이 아니라 「시술 자체」를 보장하는 특약 (질병 특정 비급여 · 신의료기술치료비 1 종 「근골 및 하지정맥류질환」 , 수술비 계열) 으로 설명한다

출처 : 대법원 2026 다 202566(연합 2026.7.23 보도) · 쿠키뉴스 2026.9.14(보험사 사전안내 ·9.9 심사 강화) · 메디팜헬스 (대한정맥통증학회 입장)

사례 3. 자궁근종 하이푸 ,「치료는 필요했지만 입원은 아니었다」. 법원은 치료 필요성과 입원 적정성을 따로 본다

고객의 생각

「시술 뒤 6 시간 넘게 병원에 있었으니 입원이지요 . 실손으로 입원비 받을 수 있지요 ?」

판정

통원 . 원고 6 명 중 1 명의 질병통원의료비 7 만 5 천원만 인정 , 입원비 전부 기각

서울중앙지법 1 심 (항소 없이 확정 , 메디컬투데이 2026.5.15).「 6 시간 체류만으로는 부족하다」. 별건 부산지법 항소심도 시술 필요성은 인정하되 입원의료비 요건은 충족하지 않는다고 판단

고객이 본 불이익

입원비 0 원 · 통원 7.5 만원

입원비 수백만원 기대 → 통원의료비 7 만 5 천원 . 나머지는 전액 본인 부담

설계사 포인트

하이푸 · 맘모톰 · 갑상선 고주파는 통원화된 대표 시술이다 . 당사「특정질환 3 대치료비」(자궁근종 고강도초음파집속술 · 유방병변 진공보조장치이용절제 · 갑상선질환 고주파열치료 , 최초 1 회) 는 입원과 무관하게 시술 자체를 본다

출처 : 메디컬투데이 2026.5.15 · 의협신문 (하이푸 판결) · 팜뉴스 (부산지법 항소심). 1 심 선고일은 보도에 없어 미확인

사례 4. 한방병원 줄기세포 주사 , 9 명이 같은 입원을 했는데 2 명만 입원이었다 . 「환자별 구분 없는 일괄 입원」은 입원이 아니다

고객의 생각

「병원에서 다들 입원해서 맞는다고 해서 입원했어요 . 옆 침대 사람도 받았대요」

판정

7 명 기각 . 병원이 환자별 상태 구분 없이 입원을 일괄 처방 . 2 명만 개별 사정이 인정

서울중앙지법 (2024 년 시술분 , 데일리메디 2026 보도). 무릎주사도 같은 논리다 . 6 시간 이상 체류했어도 개별 상태 · 합병증 위험이 의학적으로 확인되지 않으면 입원이 아니다 (팜뉴스)

고객이 본 불이익

9 명중 7 명 0 원

같은 병원 , 같은 처방인데 결과가 갈린다 . 「옆 사람은 받았다」가 근거가 되지 못한다

설계사 포인트

당사 입원일당 특약 다수는 약관 정의에서 요양병원 · 정신병원 · 한방병원을 뺀다 . 「한방병원 입원」은 실손 판정 이전에 특약 정의에서 먼저 걸린다 . 가입 때 이 한 줄을 읽어 준다

출처 : 데일리메디 2026(서울중앙지법 , 선고일 미보도) · 팜뉴스 (무릎주사). 다수 당사 입원일당 특약은 한방병원 입원을 정의에서 제외한다 (tool_body.js 원문)

사례 5. 「숙박형」 요양병원 장기입원 , 금감원이 꼽은 실손 허위청구 4 대 유형 . 고객은 간병을 받았을 뿐인데 수사 대상이 된다

고객의 생각

「요양병원에서 몇 달 지내며 치료받았어요 . 입원일당이랑 실손 다 청구해야지요」

판정

허위 장기입원 유형 . 금감원 2025.9.8 안내 사례에서 141 명 검거 . 입원 필요성 없는 「숙박」으로 판단

금감원 「실손 허위청구 4 대 유형」: 진료비 쪼개기 , 미용시술 둔갑 , 허위처방 끼워넣기 , 숙박형 요양병원 허위 장기입원 . 2024 년 실손 · 장기보험 허위 · 과다청구 2,337 억원 , 19,401 명 . 2026 년 상반기 보험사기 6,199 억 중 진단서 위변조 · 입원수술비 과다청구 1,473 억

고객이 본 불이익

보험금 환수 + 수사

보험금 환수와 형사 절차 . 심평원 입원적정성 심사로 넘어가면 평균 처리 2 년 가까이 걸린다

설계사 포인트

당사 입원일당 특약은 대부분 「요양병원 제외」 , 요양병원형은 별도 특약 (간병인사용 질병입원일당 (요양병원) 등) 으로만 설계된다 . 장기 입원이 필요한 고객에게는 「 181 일이상」 특약과 간병인지원 특약을 설명하고 , 요양병원 여부를 먼저 묻는다

출처 : 아시아투데이 2025.9.8(금감원 4 대 유형) · 이지경제 (2024 허위청구 통계) · 한국보험신문 2026(상반기 보험사기) · 메디칼타임즈 (심평원 처리일수 761 일 , 2020 국감)

사례 6. 반대로 입원이 인정된 경우 . 출혈로 도뇨관을 빼지 못한 약 6 시간 , 법원은「6 시간은 절대 기준이 아니다」라며 402 만원을 지급하라 했다

고객의 생각

「수술 뒤 피가 나서 소변줄을 못 뺐어요 . 그날 집에 못 가고 병원에 있었는데 보험사가 통원이래요」

판정

입원 인정 . 합병증으로 당일 퇴원이 어려웠고 의사 관리 아래 처치가 이어졌다 . 미지급 402 만원 지급

서울중앙지법 민사합의부 항소심 (2026.5 보도). 보험사는 복지부 고시 6 시간 기준으로 통원을 주장했으나 배척 .「6 시간 요건은 절대 기준이 아니다」. 수술명은 보도에 없다

고객이 본 불이익

통원 판정 → 402 만원

처음 통원 판정을 받고 소송까지 가서야 받았다 . 기록이 있었기에 이긴 사건

설계사 포인트

입원이 맞다면 이기는 근거는「기록」이다 . 퇴원이 늦어진 이유 (합병증 · 처치) 가 진료기록에 남도록 고객이 의사에게 말하게 한다 . 6 부「입원 전 안내 5 가지」의 셋째가 이것이다

출처 : 연합뉴스 (네이트) 2026.5.12 · 의협신문 2026. 수술명 · 사건번호는 보도에 없어 미확인

여섯 장면을 한 표로 . 공통점은 「입원 여부를 고객이 정했다」는 것 , 차이는 「기록이 있었는가」다

장면	고객의 생각	판정	불이익	당사에서 입원 없이 보장하는 길
백내장 다초점	입원 수술	통원 (대법원 2025.1)	800 만 → 20~30 만원	130·131 대질병수술비 [백내장] · 안과질환수술비
하지정맥류 이틀 입원	양다리라 이틀	형식적 입원 (대법원 2026.6)	입원의료비 0 원	특정 비급여 · 신의료기술치료비 1 종 · 수술비
자궁근종 하이푸	6 시간 넘게 있었다	통원 (서울중앙지법)	입원비 0 · 통원 7.5 만원	특정질환 3 대치료비 (하이푸 · 맘모톰 · 고주파)
한방병원 줄기세포 주사	다들 입원한다	9 명 중 7 명 기각	0 원	입원일당 정의에서 한방병원 제외를 먼저 설명
숙박형 요양병원	치료받으며 지냈다	허위 장기입원 유형	환수 + 수사	181 일이상 입원일당 · 간병인지원일당 (요양병원 여부 확인)
합병증 도뇨관	집에 못 갔다	입원 인정 (2026.5)	소송 뒤 402 만원	기록이 남는 입원이면 입원일당도 산다

입원은 「결과」이지 「선택」이 아니다 . 선택할 수 있는 것은 입원 없이도 나오는 특약을 미리 갖추는 일이다

출처 : 2 부 각 장 하단 표기와 같음 . 「당사에서 입원 없이 보장하는 길」은 당사 특약 약관 명칭 (proposal_smart/db.json) 이며 , 지급 조건 · 가입 가능 여부는 상품 · 플랜별 약관으로 확인한다

PART 03

네 가지 배경

의료기술 · 건보 재정 · 실손 손해율 · 제도 . 네 힘이 모두 「입원은 줄이고 , 심사는 늘리는」 쪽을 향한다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

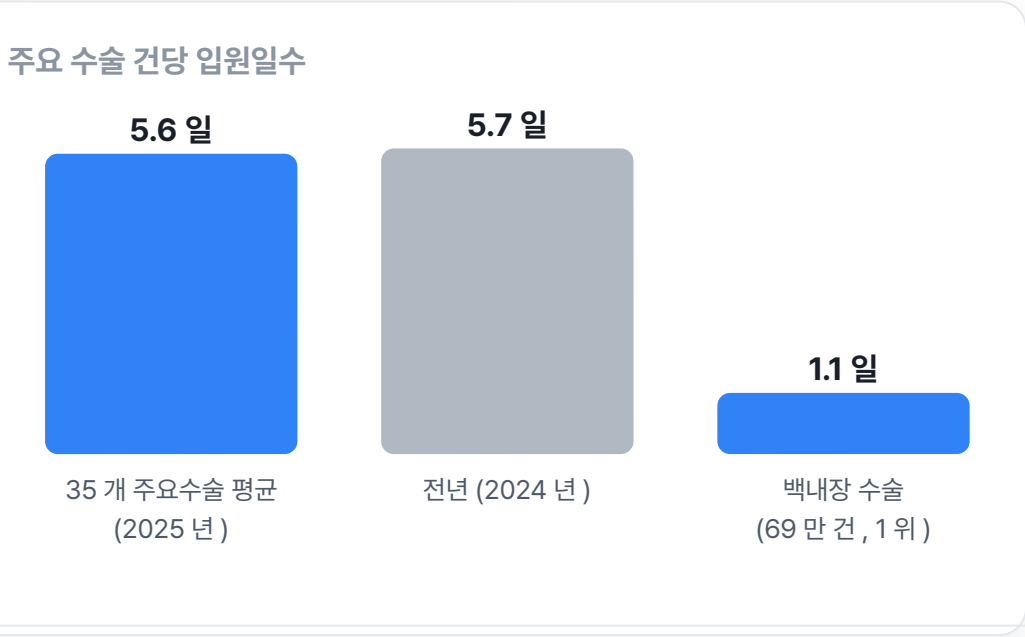
03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5 세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

치료는 빨라졌다 . 주요수술 평균 입원 5.6 일 , 백내장은 1.1 일 , 로봇수술은 10 년새 8 배 . 「입원할 일」 자체가 줄어든다



로봇수술 연 8 만 5 천 건

2015 년 약 1 만 건의 8 배 . 누적 50 만 건 육박 . 복강경보다 개복 전환이 54% 적고 입원이 짧다

항암치료의 외래화

질병관리청 : 입원하지 않고 외래에서 투여하는 항암제 치료가 늘고 있다 . 표적항암제 원외처방 5,321 억 (2024, +20.4%)

백내장 , OECD 평균 95% 가 당일수술

우리나라만의 일이 아니다 . 당일 퇴원이 세계 표준이 된 수술에 「입원」을 붙이면 심사 대상이 된다

입원 일수에 매달린 보장은 의학이 발전할수록 저절로 얇아진다 . 보장 단위를 「치료 행위」로 옮길 첫째 이유

출처 : 국민건강보험공단 「 2025 년 주요수술 통계연보」 (헬스포커스 · 병원신문 2026 보도) · 머니투데이 2026.6.30 · 연합뉴스 2026.9.17 · 질병관리청 국가건강정보포털 · OECD Health at a Glance 2025. 하이푸 · 맘모톰 등 개별 시술의 통원화 비율은 공식 통계가 없어 정성적 추세로만 말한다

건강보험은 2026 년 처음 적자로 돌아선다 . 병상은 OECD 평균의 3 배 , 재원일수는 2 위 . 「입원 억제」가 국가 재정 과제가 됐다

−2.8 조원

2026 년 건보 당기수지 연말 추계 (−2 조 8,374 억). 2025 년은 +4,996 억 , 5 년 연속 흑자였다

30.2 조원

누적 준비금 30 조 2,217 억 (2025 년 말). 국회예산정책처는 현행 유지 시 2030 년 소진을 경고

12.5 / 4.2 개

인구 1 천 명당 병상 , 한국 vs OECD 평균 (2024 년 기준 , 1 위)

17.9 일

입원환자 1 인당 평균 재원일수 , OECD 2 위 . 급성기 7.3 일

44.9%

건보 진료비 116 조 중 65 세 이상 몫 (2024). 노인 1 인당 연 551 만원 , 전체 평균의 2.4 배

재정이 입원을 바라보는 방식

2026 보험료율 7.19% → 2027 동결 (국고 +1.1 조) → 2026.12 수가 개편 3.6 조 → 장기입원 체감제 확대 논의

국가가 입원을 아끼기 시작하면 병원도 입원 기준을 조인다 . 고객의 입원은 점점 「관찰 후 귀가」와 「통원」이 된다

출처 : 한국경제 · 파이낸셜뉴스 2026.10.13(건보공단 중장기 재무관리계획) · 뉴스핌 2026.1.28(2025 년 결산) · 경향신문 2025.8.18(국회예산정책처) · 보건복지부 「 OECD 보건통계 2026 」 분석 (아시아경제 2026.7.23) · 건정심 2025.8.28, 2026.9.8 · 뉴스핌 2025.11.28(고령화 진료비). 체감제 확대는 보도 단계의 논의이며 확정 수치는 아니다

실손은 2025 년 손해율 101%, 적자 1 조 8,700 억 . 보험금의 57% 가 비급여다 . 보험사는 「입원이 맞았나」를 더 자주 , 더 깊이 본다

세대별 경과손해율 (2025 년 , 금감원 잠정)



100% 선 = 받은 보험료만큼 보험금을 준 상태

비급여 보험금 9 조 6,884 억

전체 지급보험금 17 조의 57.1%. 근골격계 2 조 6,900 억이 암 · 뇌 · 심 2 조 5,500 억보다 크다

비급여 상위 : 도수치료 1 조 3,858 억

비급여 주사제 6,525 억 · 체외충격파 5,110 억 · 척추 수술 2,768 억 · 증식치료 2,583 억 (2024 년 말 , 보험연구원)

의료자문 뒤 부지급 10.5%

상반기 손보 청구 4,581 만 건 중 의료자문 22,435 건 , 그중 2,347 건 부지급 . 거절 평균 1,618 만원

보험사기 적발 1 조 1,571 억 (2025)

2026 년 상반기 6,200 억 (+9.1%) 으로 역대 상반기 최대 . 장기보험이 39.8%

손해율이 100% 를 넘으면 보험사는 지급을 줄일 수 있는 곳부터 본다 . 「입원의 적정성」은 그중 가장 큰 칸이다

출처 : 금융감독원 「 2025 년 실손의료보험 사업실적 (잠정) 」 2026.6.3(파이낸셜뉴스 · 국민일보 · 이투데이 보도) · 보험연구원 (머니투데이 2025.12.11) · 경향신문 2026.6.7(의료자문) · 금감원 보험사기 적발 실적 (뉴스핌 2026.9.28). 의료자문 통계는 상반기 16 개 손보사 기준

제도는 2024 년부터 한 방향으로 움직였다 . 보험사기법 개정 , 비급여 · 실손 개혁 , 5 세대 출시 , 도수치료 관리급여 , 전환 할인

2024. 8. 14

보험사기방지특별법 개정 시행

알선 · 유인 · 광고 금지 (10 년 이하 징역). 금융당국 조사권 강화 . 심평원 입원적정성 심사 기준 마련 근거

2025. 1. 9

비급여 관리 · 실손 개혁방안 발표

실손을 중증 중심으로 재편 . 재가입 조항 없는 1·2 세대 1,582 만 건 (44%) 재매입 검토

2026. 5. 6

5 세대 실손 출시 (16 개사)

비중증 비급여 자기부담 50%· 연 1 천만원 , 도수 · 체외충격파 · 비급여 주사 제외 . 중증은 입원 자기부담 상한 500 만원

2026. 7. 1

도수치료 관리급여 시행

회당 43,850 원 단일 수가 , 본인부담 95%, 주 2 회 · 연 15 회

2026. 11

1·2 세대 → 5 세대 전환 할인

5 세대 보험료 3 년간 50% 할인 , 6 개월 한시 . 현금 재매입 대신 택한 방식

외울 날짜는 셋이다 . 2024.8 심사 근거 , 2026.5 5 세대 , 2026.11 전환 할인 . 고객의 질문이 여기서 나온다

출처 : 뉴시스 2024.8.13 · 정책브리핑 (법 개정) · 금융위원회 보도자료 2025.1.9 · 금융위원회 보도자료 2026.5(5 세대) · 보건복지부 보도자료 2026.6(관리급여) · 머니투데이 2026.5.5(전환 할인). 전환 할인의 11 월 시행 세부 약관은 금융위 11 월 발표로 확인 필요

네 힘이 한 방향

입원은 줄이고 ,
입원 심사는 늘린다

의료기술은 입원할 일을 줄이고 , 건보 재정은 입원을 억제하고 , 실손 손해율은 심사를 늘리고 ,
제도는 비급여를 관리한다 . 어느 하나도 「입원일당」 편이 아니다

의료기술
입원 5.6 일 → 더 짧게

건보 재정
2026 년 – 2.8 조

실손
손해율 101%

제도
5 세대 · 전환 할인

PART 04

실손 재매입과 5 세대

「보상금 받고 해지」는 「5 세대로 갈아타면 3 년 반값」이 됐다. 실손이 얇아질수록 정액 특약의 자리가 넓어진다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 **실손 재매입과 5 세대**

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

실손 다섯 세대 , 한 표로 본다 . 세대가 올라갈수록 자기부담은 커지고 비급여 한도는 줄어든다 . 「입원」의 값도 함께 줄었다

구분	1 세대	2 세대	3 세대	4 세대	5 세대
가입 시기	2009.9 이전	2009.10 ~ 2017.3	2017.4 ~ 2021.6	2021.7 ~ 2026.5	2026.5.6 ~
보유 계약 (2025 년 말)	618 만 건 (17.1%)	1,494 만 건 (41.2%)	783 만 건 (21.6%)	641 만 건 (17.7%)	출시 첫 달 신규 4.3 만 건
경과손해율 (2025 년)	102.3%	93.1%	120.3%	115.1%	-
2026 년 보험료 인상	3% 대	5% 대	16% 대	20% 대	4 세대 대비 약 30% 저렴 (당국 추산)
비중증 비급여 자기부담	없음 또는 낮음	10~20%	특약 30%	특약 30%	50% · 연 1,000 만원 · 도수 · 주사 · 체외충격파 제외
재가입 (약관 변경) 조항	없음 (2013.3 이전)	없음 (2013.3 이전)	15 년	5 년	5 년
이번 전환 할인 대상	대상	대상 (2013.3 이전 계약)	-	-	전환 받는 쪽

증권의 「가입 연월」 하나만 읽어도 세대가 보이고 , 세대가 보이면 전환 할인 대상인지가 보인다

출처 : 금융감독원 「 2025 년 실손의료보험 사업실적 (잠정) 」 2026.6.3 · 헤럴드경제 2025.12.30(인상률) · 금융위원회 보도자료 2026.5(5 세대) · 머니투데이 2026.5.5(전환 할인 대상). 1·2 세대 자기부담률은 상품 · 시기별로 달라 대표값이며 , 5 세대 통원 한도 「하루 20 만원」은 입법예고 기준으로 최종 약관 확인 권장

5 세대는 「중증은 두껍게 , 비중증은 얇게」. 비중증 비급여는 절반을 내 돈으로 내고 , 도수 · 체외충격파 · 비급여 주사는 아예 빠진다

급여

입원 자기부담 20%

입원 자기부담 20% 유지 . 통원은 건보 본인부담률에 연동 (의원 30% · 병원 40% · 종합 50% · 상급종합 60%). 임신 · 출산 · 발달장애 급여 신규 보장

중증 비급여 (특약 1)

상한 500 만원

연 5,000 만원 한도 , 자기부담 30% 유지 . 상급종합 · 종합병원 입원 시 연간 자기부담 상한 500 만원 신설 . 통원은 30% 와 3 만원 중 큰 금액

비중증 비급여 (특약 2)

자기부담 50%

연 한도 5,000 만 → 1,000 만원 , 자기부담 30 → 50%. 입원 회당 300 만원 , 통원 하루 20 만원 (50% 와 5 만원 중 큰 금액). 도수치료 · 체외충격파 · 비급여 주사제 제외

전환 실적은 아직 미미하다 . 1·2 세대에서 5 세대로 자발적 전환은 9 월 말 33,577 건 , 보유 1,643 만 건의 약 0.2%(뉴스핌 2026.9.2 · 아주경제 2026.10.15). 그래서 11 월 「 3 년 반값」 카드가 나왔다

5 세대 가입자에게 도수 · 주사 · 비급여 통원은 실손이 거의 못 막는다 . 그 자리를 채우는 것이 정액 치료비 · 수술비다

출처 : 금융위원회 보도자료 2026.5 · 블로터 2026.5 · 뉴스 1 2026.1.15 · 머니투데이 2026.5.5 · 보건복지부 2026.6(도수치료 관리급여 2026.7.1 시행). 세부 자기부담 수치는 최종 약관에서 확인한다

「재매입」은 현금 보상에서 「전환 할인」으로 바뀌었다 . 2026 년 11 월부터 6 개월 , 1·2 세대가 5 세대로 가면 보험료를 3 년간 절반만 낸다

- **2025. 1** — 계약 재매입 검토 발표 . 1,582 만 건 (44%) 대상
- **2025. 12** — 「보험료 − 받은 보험금」 차액 보상안 업계 제시
- **2026. 1** — 시행령 개정안에서 재매입 조항 제외 . 보험사 「조 단위 비용」 반발
- **2026. 5. 5** — 전환 할인으로 확정 : 5 세대 보험료 3 년 50%, 11 월 시행 · 6 개월 한시
- **2026. 9** — 주계약 유지한 채 실손 「특약」으로 전환 허용 . GA 부당 승환 관리 강화

금융당국 시뮬레이션 예시 · 1 세대 60 대 여성

월 178,489 원 → 월 21,270 원

5 세대 전환 + 3 년 50% 할인 적용 . 3 년 누적 약 559 만원 절약 사례 (파이낸셜뉴스 2026.5.6 · 헤럴드경제 2026.9). 단 , 보장도 5 세대 구조로 바뀐다

대상

2013. 3 이전 가입 , 재가입 조항 없는 1·2 세대

기간

2026. 11 시행 , 6 개월 한시 운영 뒤 연장 검토

철회

할인 신청 뒤 6 개월 안에 청약철회 가능

다른 길

유지 + 선택형 할인 특약 (비급여 일부 제외 시 30~40% 인하 예상)

고객의 질문은 「갈아타야 하나요」다 . 답은 보험료가 아니라 「지난 3 년 무엇으로 얼마를 받았나」에서 나온다

출처 : 금융위원회 보도자료 2025.1.9 · 한국경제 2025.12.8 · 뉴스핌 2026.1.16 · 머니투데이 2026.4.3, 2026.5.5, 2026.9.11 · 시사오늘 2026.5 · 파이낸셜뉴스 2026.5.6. 「현금 재매입 폐기」는 공식 문구가 아니라 보도 흐름에서 읽은 추정이며 , 11 월 시행 세부 (약관 · 참여 보험사) 는 금융위 발표로 확인한다

전환 상담은 세 갈래다 . 지난 3 년 청구 이력으로 갈래를 나누고 , 어느 갈래든 「실손이 비운 자리」를 정액 특약으로 채운다

A 유지

지난 3 년 비급여 통원 · 도수 · 주사 청구가 잦은 고객

1·2 세대 보장 (낮은 자기부담) 이 아직 유리 . 다만 보험료 인상 (1 세대 3% 대 , 2 세대 5% 대) 과 손해율 102% 는 계속 오른다는 뜻

B 전환 + 할인

청구가 거의 없고 보험료 부담이 큰 60 대 이상

3 년 50% 할인의 효과가 가장 크다 . 대신 비중증 비급여 자기부담 50%, 도수 · 주사 제외를 반드시 설명하고 6 개월 철회권을 알린다

C 유지 + 선택형 할인

보장은 지키고 싶지만 보험료를 줄이고 싶은 고객

비급여 일부 제외 · 자기부담 상향으로 30~40% 인하 예상 . 제외한 항목은 정액 특약으로 메운다

어느 갈래든 공통 — 실손이 비운 자리 → 도수 · 주사 → 치료비 정액 → 입원 축소 → 수술비 · 통원일당 → 비급여 신의료기술 → 특정치료비

전환 할인은 보험료 상담이 아니라 보장 재설계의 입구다 . 5 부의 특약 지도가 그 다음 장이다

주 : 세 갈래의 기준은 교육용 상담 틀 (가정값) 이며 금융당국 지침이 아니다 . 전환 권유 시 부당 승환 (금융위 2026.9 감독규정 개정 예고) 에 해당하지 않도록 비교 안내 서류를 남긴다

PART 05

당사 특약 점검

지급 조건이 「입원」인 특약과 「치료 행위」인 특약으로 갈라 본다 . 앞은 설명 의무가 커지고 , 뒤는 가치가 오른다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5 세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

특약 지도 . 왼쪽으로 갈수록 「입원」이 지급 조건이고 , 오른쪽으로 갈수록 「치료 행위」가 조건이다 . 트렌드는 오른쪽으로 흐른다

입원이 조건 (입원적정성 논란에 노출)

입원 + 다른 조건

치료 행위가 조건 (입원 여부와 무관)

입원일당 계열

질병입원일당 (1 일이상) · 일반상해입원일당 (1 일이상) · 질병입원일당 (181 일이상)(요양 , 정신 , 한방병원제외) · 상급종합병원 질병입원일당 · 종합병원 질병입원일당 · 질병중환자실입원일당

입원 + 병실 · 간병 조건

상급병실 (1 인실) 상급종합병원 질병입원일당 (10 일한도) · 2-3 인실 종합병원 질병입원일당 (30 일한도) · 간병인사용 질병입원일당 (plus) · 간호 · 간병통합서비스 사용 질병입원일당

입원 + 직접치료 조건

암직접치료입원일당 (II)(요양병원제외) · 종합병원암직접치료입원일당 (365 일한도) · 암요양병원입원일당 (II) (90 일한도) · 뇌출혈입원일당 (4 일이상) · 급성심근경색증입원일당 (4 일이상)

통원 · 낮병동 · 응급실

뇌혈관질환통원일당 (연간 30 회 한) · 허혈성심장질환통원일당 · 암직접치료통원일당 (상급종합병원) · 종합병원암직접치료낮병동입원일당 (연간 20 일) · 응급실내원비 (응급) · 일반상해입원후통원비

수술 · 치료 · 검사

수술비II (1-5 종) · 수술비 (1-7 종 , 연간 3 회한) · 1-5 종수술비 (plus) · 표적항암약물허가치료비 (약물 개수별) · 항암방사선약물치료비 · 암 ·2 대질환 주요치료비 (연간 1 회 , 10 년) · 특정 비급여 · 신의료기술치료비 (1-4 종) · 특정질환 3 대치료비 · 통합치료비 · MRI·CT·PET 검사비 · 통합생활지원비

주 : 특약 명칭은 당사 약관 명칭 (proposal_smart/db.json, 1,765 개 중 발췌). 「입원 + 직접치료」 칸은 입원 요건에 암 직접치료 요건이 더해져 심사 쟁점이 둘이다 . 가입 가능 여부와 세부 지급 조건은 상품 · 플랜별 약관으로 확인한다

입원일당은 나쁜 특약이 아니다 . 다만 「입원」 한 단어에 세 가지 조건이 숨어 있어 , 팔 때 세 줄을 읽어 주지 않으면 민원이 된다

조건 1 · 병원 종류

요양병원 · 정신병원 · 한방병원 제외

「질병입원일당 (181 일이상)(요양 , 정신 , 한방병원제외) 」처럼 이름에 쓰인 것도 있고 , 「질병입원일당 (1 일이상) 」처럼 약관 정의 안에만 있는 것도 있다 . 사례 4·5 가 여기서 걸린다

조건 2 · 입원의 실질

6 시간 · 관찰 기록 · 개별 필요성

백내장 · 하이푸 · 정맥류 판결의 기준이 그대로 적용된다 . 입원일당은 실손보다 금액이 작아 다툼이 적을 뿐 , 요건은 같다

조건 3 · 기간과 한도

1 일이상 / 4 일이상 / 30 일 · 180 일 · 365 일 한도

뇌출혈 · 급성심근경색증입원일당은 4 일이상 , 상급병실 1 인실은 10 일한도 , 중환자실은 별도 . 재원일수 5.6 일 시대에 「 4 일이상」은 실제로 못 받는 경우가 생긴다

그래도 입원일당이 사는 자리 : 뇌졸중 · 심근경색 · 암 수술처럼 기록이 남는 「진짜 입원」 , 중환자실 , 181 일 이상 장기 입원 . 즉 입원일당은 「가벼운 입원」이 아니라 「무거운 입원」용으로 설명한다

「며칠 누우면 얼마」가 아니라 「이런 병원에서 , 이런 치료로 , 이 기간 이상 입원하면」으로 세 조건을 먼저 말한다

출처 : 당사 특약 약관 정의 (tool_body.js) · 특약 명칭 (db.json) · 2 부 판례 . 재원일수 5.6 일은 건보공단 2025 년 주요수술 통계연보

조건이 둘이면 쟁점도 둘이다 . 간병인「사용」영수증 , 1 인실「배정」, 암「직접치료」가 입원 요건 위에 얹힌다

특약 (약관 명칭)	입원 요건 위에 얹힌 조건	현장에서 생기는 오해	설명할 때 한 줄
간병인사용 질병입원일당 (plus)(1 일이상 180 일한도) (요양병원제외)	유상 간병인 사용 사실 + 사업자 등록 확인 (약관「간병인」정의)	가족 간병 , 미등록 간병인은 대상이 아니다 . 요양병원 입원은 별도 특약	「간병인을 직접 구해 쓴 날 , 영수증이 있는 날」
갱신형 간병인지원 질병입원일당 (VII)(1 일이상 180 일한도)	회사가 간병인을 보내 주는 서비스형 (지원). 입원 자체는 요건	사용형과 지원형을 섞어 설명하면「왜 돈이 안 나오나」가 된다	「불러 드리는 간병인」vs「직접 쓰고 받는 일당」
상급병실 (1 인실) 상급종합병원 질병입원일당 (1 일이상 10 일한도)	1 인실 배정 + 상급종합병원 + 10 일 한도	다인실 대기 중 하루 1 인실 , 2-3 인실은 다른 특약	「상급종합 1 인실에 실제로 든 날 , 열흘까지」
암직접치료입원일당 (II)(요양병원제외 , 1 일이상)	암의「직접치료」목적 입원 . 합병증 · 후유증 · 요양 목적은 제외	항암 뒤 체력 회복 입원 , 요양병원 입원이 가장 많이 다툰다	「암을 없애는 치료를 위한 입원」, 요양은 암요양병원입원일당 (90 일한도) 으로
종합병원 전신마취치료비 (급여 , 6 시간이상)	전신마취 6 시간 이상 (4 시간 이상 특약도 있음)	마취 시간은 수술 기록에 남는다 . 입원 여부와는 별개	「긴 수술을 받으면」, 입원일수는 묻지 않는다

둘째 조건이 있는 특약은「입원 + ○○ 」로 끊어 읽어 준다 . ○○ 가 고객의 기억에 남아야 청구할 때 서류가 준비된다

출처 : 당사 약관「입원」·「간병인」정의 (tool_body.js) · 특약 명칭 (db.json).「암직접치료」의 세부 범위 (합병증 · 후유증 · 요양 제외) 는 해당 특약 약관 조문으로 확인한다

입원이 통원이 되는 시대의 첫 수혜자 . 통원일당 · 낮병동입원일당 · 응급실내원비는 「입원 아님」 판정이 나도 그 자리에서 지급 사유가 된다

뇌혈관질환통원일당 (연간 30 회한)

허혈성심장질환통원일당 (연간 30 회한) · 상급종합병원형 · 종합병원형

뇌 · 심장은 급성기 입원이 짧아지고 외래 추적이 길어진다 . 연 30 회면 한 달 2~3 회 외래를 1 년 내내 받는다

탑재 : 케어프리 · 통합간편

암직접치료통원일당 (상급종합병원)

감액 및 면책기간 미적용형 있음

항암은 외래 투여가 늘고 표적항암제는 처방 환자의 약 40%(아이큐비아). 입원 없는 항암의 날수를 세어 준다

탑재 : 또또암 · 또또암간편 · 케어프리 · 통합간편

종합병원암직접치료낮병동입원일당 (급여 , 1 일 1 회한 , 연간 20 일한도)

낮병동 (6 시간 이상 관찰 · 치료 후 귀가) 을 「입원」으로 명시

백내장 · 하이푸처럼 「입원 아님」이 되는 하루를 특약 이름부터 낮병동으로 받아 준다

탑재 : 또또암 · 또또암간편

응급실내원비 (응급) · 응급실내원비 (1-3 등급)

의료기관 및 민간 구급차 이용형 있음

응급실에서 처치 · 관찰 뒤 귀가한 하루는 입원이 아니다 . 내원 자체를 보장한다

탑재 : 케어프리 · 운전자

통원 판정이 나도 그 자리에서 지급 사유가 되는 네 특약 . 입원일당과 짝으로 설계하면 「입원 아님」의 날이 비지 않는다

출처 : 당사 특약 명칭 · 탑재 상품 (db.json) · 당사 약관 「낮병동 입원 (급여) 」 정의 · 질병관리청 국가건강정보포털 (항암 외래화) · 아이큐비아 (네이트 2026.3.23). 탑재 상품 표기는 db.json 기준이며 판매 중 플랜은 상품 안내로 확인

약관의 「수술」 정의에는 입원이 없다 . 수술비 · 치료비 · 검사비는 「무엇을 받았나」만 묻는다 . 5 세대 실손이 비운 비급여 자리를 메우는 것도 이쪽이다

수술비 계열

수술비II (1-5 종) · 수술비 (1-7 종 , 연간 3 회한) · 질병 1-5 종수술비 (plus)(연간 2 회이상) · 130·131 대질병수술비 · 폴립및양성종양수술비 (1-6 종)

「수술」 = 의사가 필요 인정 + 기구로 절단 · 절제 등의 조작 . 신의료기술 수술 포함 . 당일수술이 늘수록 쓰임이 는다

항암 치료비

표적항암약물허가치료비 (연간 약물종류 개수별) · 항암방사선약물치료비 · 특정면역항암약물허가치료비 · 비급여 항암약물치료비 (연간 1 회한 , 10 년간)

외래 항암의 시대 . 약물 종류 개수별로 매년 반복 지급되는 구조는 입원일수와 무관하다

주요치료비 · 통합치료비

암 주요치료비 (연간 1 회한 , 10 년간) · 2 대질환 주요치료비 · 암 통합치료비 (기본형) · 질병 · 상해 통합치료비 · 특정순환계질환 통합치료비

검사 (MRI·CT·PET) · 수술 (1-5 종) · 주요치료 (시술 ·CRRT· 전신마취 6 시간 등) 항목별 지급 . 약관 예시에 「외래 1 회 + 입원 1 회」가 따로 세어진다

비급여 · 신의료기술 치료비

질병 특정 비급여 , 신의료기술치료비 (1-4 종): 1 종 근골 및 하지정맥류 · 2 종 기타질환 · 3 종 로봇보조 · 4 종 여성 비뇨생식기 · 특정질환 3 대치료비 (하이푸 · 맘모톰 · 갑상선 고주파)

2 부의 정맥류 · 하이푸 · 맘모톰이 모두 여기 있다 . 5 세대 실손이 비중증 비급여를 50% 자기부담으로 만든 자리

검사비 · 생활지원

암 MRI 촬영검사비 · 암 CT 촬영검사비 · PET 검사비 · 3 대질환 MRI 촬영검사비 · 암 통합생활지원비 (월간한도) · 2 대질환 통합생활지원비

진단 전 검사와 치료 뒤 생활비 . 입원 전후의 「입원 아닌 날」을 채운다

로봇 · 특수 수술

다빈치로봇 암수술비 · 뇌정위적방사선수술비 (급여) · 기계적혈전제거술 (카테터법) 치료비II · 항암양성자 · 중입자방사선치료비

로봇수술 연 8.5 만 건 (2015 년의 8 배). 입원은 짧아지고 치료 단가는 올라가는 영역

출처 : 당사 약관 「수술」 · 「통합치료」 정의와 예시 (tool_body.js) · 특약 명칭 (db.json) · 머니투데이 2026.6.30(로봇수술) · 금융위 2026.5(5 세대). 지급 금액 · 횟수 · 면책은 특약별 약관 지급표를 따른다

트렌드 적합도로 매긴 잠재력 순위 . 네 배경 (의료기술 · 건보 · 실손 · 제도) 각각에 얼마나 올라타는지를 별로 셌다

순위	특약 (약관 명칭)	입원 의존	통원화 수혜	비급여 관리 수혜	적합도	한 줄 판매 포인트
1	표적항암약물허가치료비 (연간 약물종류 개수별)	없음	높음	높음	★★★★	외래 항암 · 약물 개수별 매년 반복 . 입원일수와 무관
2	질병 특정 비급여 , 신의료기술치료비 (1-4 종) · 특정질환 3 대치료비	없음	높음	매우 높음	★★★★	정맥류 · 하이푸 · 맘모톰 · 로봇 . 5 세대가 비운 자리
3	수술비II (1-5 종) · 수술비 (1-7 종) · 1-5 종수술비 (plus)	없음	높음	중간	★★★★	당일수술이 늘수록 청구가 는다 . 백내장도 수술
4	암 · 질병 · 상해 통합치료비 · 주요치료비 (연간 1 회 , 10 년)	낮음 (항목별)	높음	높음	★★★☆	검사 · 수술 · 시술을 항목별로 . 외래 1 회 + 입원 1 회 따로 센다
5	뇌혈관 · 허혈성심장질환 통원일당 · 암직접치료통원일당	없음	매우 높음	낮음	★★★☆	입원이 짧아진 만큼 길어진 외래를 날수로
6	종합병원암직접치료낮병동입원일당 · 응급실내원비	없음	높음	낮음	★★★☆	「입원 아님」이 되는 하루를 이름부터 받아 준다
7	간병인지원 입원일당 (서비스형) · 통합생활지원비	있음 / 없음	중간	중간	★★☆☆	입원하면 사람을 보내고 , 치료 뒤 생활비를 준다
8	입원일당 (1 일이상) · 상급병실 · 중환자실 입원일당	높음	낮음	낮음	★☆☆☆	「무거운 입원」 전용으로 세 조건과 함께 판다

위 세 줄 (표적항암 · 비급여 신의료기술 치료비 · 수술비) 이 입원적정성 시대의 앞자리다 . 입원일당은 뒤에서 받친다 . 별점은 이 교안의 평가 (가정값) 이며 회사 공식 등급이 아니다 . 「입원 의존」은 약관 지급 조건에 입원이 있는지 , 「통원화 수혜」는 입원 감소 추세에서 청구 가능성이 느는지 , 「비급여 관리 수혜」는 5 세대 실손 · 관리급여로 실손 보장이 줄어 정액 보장의 필요가 커지는지를 뜻한다

PART 06

현장 실천

상담 화법 세 문장 , 입원 전 안내 다섯 가지 , 그리고 정리

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5 세대

05 당사 특약 점검

06 **현장 실천**

세 문장이면 된다 . 「입원이 줄어든다」로 열고 , 「입원은 고객이 정하지 못한다」로 이어 , 「치료 행위를 보장받자」로 닫는다

혹시 백내장이나 정맥류 수술 받으신 분 주변에 계세요 ? 요즘은 수술하고 그날 집에 가는 게 보통이에요 . 주요수술 평균 입원이 5.6 일 , 백내장은 1.1 일이에요 .

그래도 입원하면 입원비는 나오는 거 아니에요 ?

입원했는지는 병원 침대가 아니라 약관이 정해요 . 작년 대법원에서 백내장 입원 137 명이 전부 통원으로 판정됐고 , 올해는 정맥류 이틀 입원도 통원이 됐어요 . 그래서 요즘 설계는 「며칠 입원했나」가 아니라 「무슨 치료를 받았나」로 해요 .

그럼 뭘 봐야 해요 ?

수술비 , 치료비 , 통원일당이에요 . 입원을 했든 안 했든 수술을 했으면 수술비 , 항암을 받았으면 치료비 , 외래를 다녔으면 통원일당 . 고객님 증권에서 이 세 칸부터 같이 볼게요 .

열기 입원이 줄어든다

주요수술 5.6 일 · 백내장 1.1 일 · 로봇수술 8 배

잇기 입원은 고객이 정하지 못한다

대법원 2025.1 백내장 · 2026.6 정맥류 · 당사 9 월 심사 강화

닫기 치료 행위를 보장받자

수술비 · 치료비 · 통원일당 , 증권의 세 칸

주 : 화법 속 수치는 3 부 ·2 부 출처와 같다 (건보공단 2025 주요수술 통계연보 · 대법원 2024 다 305643 · 대법원 2026 다 202566 · 쿠키뉴스 2026.9.14). 고객 앞에서 「보험사기」라는 말은 쓰지 않는다

고객이 입원하기 전에 전화로 알려 줄 다섯 가지 . 이 다섯이 지켜지면 통원 판정은 줄고 , 판정을 받아도 다툴 근거가 남는다

1	**병원 종류를 먼저 묻는다**	요양병원 · 정신병원 · 한방병원이면 입원일당 특약 정의에서 빠질 수 있다 . 상급종합 · 종합병원이면 전용 일당이 있다
2	**「왜 입원이 필요한지」를 의사에게 묻게 한다**	합병증 위험 , 마취 종류 , 당일 귀가가 어려운 이유 . 이 대답이 진료기록에 남아야 한다 (사례 6 의 402 만원)
3	**입원 중 외출 · 외박을 하지 않는다**	「의사의 관리 하에 치료에 전념」이 약관 요건이다 . 외출 기록은 실질적 입원을 부정하는 근거가 된다
4	**양쪽 · 두 부위를 나눠 입원하지 않는다**	하지정맥류 대법원 판결의 핵심 . 같은 날 통원으로 가능한 치료를 이틀로 나누면 형식적 입원이 된다
5	**입원이 아니어도 나오는 특약을 같이 청구한다**	수술비 · 치료비 · 통원일당 · 낮병동입원일당 · 응급실내원비 . 통원 판정이 나도 이 특약들은 그대로 산다

다섯 가지의 공통점은 「기록」이다 . 입원이 맞다면 기록이 지켜 주고 , 입원이 아니라면 기록이 미리 말해 준다

출처 : 당사 약관 「입원」 정의 · 대법원 2026 다 202566 · 연합 2026.5.12(402 만원 판결) · 데일리메디 2026(한방병원). 안내 문구는 교안의 제안이며 보상 안내 공식 문서가 아니다

네 문장을 들고 나간다

1

입원은 줄고 심사는 는다

의료기술 · 건보 재정 · 실손 손해율 · 제도 , 네 힘이 한 방향이다

2

입원은 결과이지 선택이 아니다

백내장 · 정맥류 · 하이푸 · 줄기세포 주사 , 고객이 정한 입원은 통원이 됐다

3

실손은 얇아지고 , 정액은 넓어진다

5 세대 비중증 50% 자기부담 , 1·2 세대 전환 할인 . 비운 자리는 수술비 · 치료비가 채운다

4

「며칠 입원」이 아니라 「무슨 치료」

입원일당은 무거운 입원용으로 세 조건과 함께 , 수술비 · 치료비 · 통원일당은 앞자리로

오늘 할 일 하나 . 고객 증권 세 장을 꺼내 「입원일당」 칸과 「수술비 · 치료비 · 통원일당」 칸을 나란히 적어 본다

출처와 한계 . 모든 수치는 아래 자료의 보도 · 발표값이며 , 원문을 직접 열어 확인하지 못한 항목은 「원문 확인 권장」으로 둔다

판례 · 감독

서울고법 2021 나 2013354(2022.1.20, 대법원 2022.6.16 확정) · 대법원 2024 다 305643(2025.1.23) · 대법원 2026 다 202566(2026.6.11) · 대법원 2004 도 6557(2006.1.12) · 금감원 보도자료 2025.3.10, 2025.9.8 · 금감원 금융민원 동향 2026.4.21 · 금감원 제 2 차 금융소비자보호 토론회 2025.11.18 · 금감원 행정지도 2026.6.22

제도 · 정책

보험사기방지특별법 개정 (2024.8.14 시행) · 심평원 공고 2024-193 호 · 금융위 보도자료 2025.1.9, 2026.5(5 세대), 2026.5.5(전환 할인), 2026.9.11 · 보건복지부 2026.6(도수치료 관리급여) · 건정심 2025.8.28, 2026.9.8, 2026.6.25

통계

금감원 2025 년 실손 사업실적 (잠정) 2026.6.3 · 보험연구원 (비급여 상위 항목) · 건보공단 2025 년 주요수술 통계연보 · 건보공단 중장기 재무관리계획 (2026.10.13 보도) · 국회예산정책처 2025.8 · 보건복지부 OECD 보건통계 2026 분석 · OECD Health at a Glance 2025 · 금감원 보험사기 적발 실적

한계 · 추정 표기 항목

- 조사 방식 : 검색 엔진이 돌려준 기사 · 보도자료 요약을 근거로 했고 원문 전문을 직접 연 항목은 없다 . 교육 전 핵심 수치는 원문 URL 을 한 번 연다
- 실손 표준약관 본문의 「 6 시간」 문구 유무는 미확인 . 6 시간은 복지부 고시 (낮병동) 와 판례에서 온 기준으로 설명했다
- 심평원 입원적정성 심사의 전국 「부적정 판정 비율」은 공개 통계가 없다
- 하이푸 1 심 선고일 , 402 만원 판결의 수술명 , 한방병원 판결 선고일은 보도에 없다
- 5 세대 통원 「하루 20 만원」 , 전환 할인 11 월 세부 약관은 최종 발표로 확인한다
- 5 부 잠재력 별점과 4 부 상담 세 갈래는 이 교안의 가정값이다

당사 자료 : 특약 약관 원문 (tool_body.js) · 특약 마스터 (proposal_smart/db.json, 1,765 개) · 디자인은 첨부 「 55 PLAN 부산센터 교육」 HTML 의 토큰 (Pretendard · #3182F6 · #191F28 · 24px 카드) 을 따랐다